# 2025 AHA/ACC 고혈압 가이드라인, 미국 목표 혈압 <130/80 mmHg

미국 지침은 모든 성인 적용(국내 일반 목표 <140/90) · 130-139/80-89 mmHg
저위험군도 3-6개월 생활습관 후 약물치료 권고 — SPRINT·STEP·칼륨대체염 연구 근거

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 2025 가이드라인 — 무엇이 달라졌나

2017년 분류는 유지하되, 약물치료 시작 기준이 더 빨라지고 가정혈압이 더 중요해졌습니다

**<130/80**

**미국 지침 모든 성인 목표**
**(국내 일반 <140/90)**

**46.7%**

**미국 성인**
**고혈압 유병률**

**3-6개월**

**저위험군 생활습관**
**후 약물치료 시작**

## 이 수치가 뜻하는 것

핵심 변경 — 130-139/80-89 mmHg + 저위험군(10년 동맥경화성 심혈관질환 위험 <7.5%)이라도 생활습관 3-6개월 후 미개선 시 약물치료를 권고합니다.
가정혈압 측정·DASH 식이·저나트륨·고칼륨이 1차 치료의 핵심 축입니다. 5월 영향분석에 따르면 미국 성인 중 약물치료 대상자가 수백만 명 추가 확대될 전망입니다.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · 2025 AHA/ACC HTN Guideline, Circulation 2025 Sept · Hypertension 2025

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 혈압 범위에 따라 이렇게 대처하세요

미국 지침의 진료실 혈압(2회 이상 평균) 분류 — 가정혈압은 국내 기준 135/85 이상이 고혈압

| 구분 | 위 혈압 | 아래 혈압 | 이렇게 하세요 |
|---|---|---|---|
| **정상** | 120 미만 | 80 미만 | 생활습관을 유지하고 정기적으로 측정합니다. |
| **혈압 상승** | 120~129 | 80 미만 | 생활습관을 점검하고 매년 평가합니다. |
| **1기 고혈압** | 130~139 | 80~89 | 위험도에 따라 생활습관 관리와 약물치료를 결정합니다. |
| **2기 고혈압** | 140 이상 | 90 이상 | 생활습관 관리와 약물치료를 함께 시작합니다. |
| **중증 고혈압** | 180 이상 | 120 이상 | 증상이 있으면 응급실, 증상이 없어도 신속히 외래에서 평가받습니다. |

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · 2025 AHA/ACC HTN Guideline 진료실 혈압 분류 · 대한고혈압학회 2022 가정혈압 기준

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 가정혈압 측정 — 진료실보다 더 중요해졌습니다

새 지침도 가정혈압을 핵심 근거로 봅니다 — 자세한 측정법은 가정혈압 안내문을 드립니다

## 정확한 가정혈압 측정법

측정 전 5분 안정 — 의자에 앉아 발 바닥에 평평히, 등 받침
아침·저녁 각 2회 — 1분 간격, 평균치 기록
커피·운동·흡연 30분 후 — 카페인·니코틴 영향 회피
팔 심장 높이 — 책상 위 팔 받침, 위팔 커프 사용
대화·휴대폰 금지 — 측정 중 침묵, 다리 꼬지 않기
※ 가정혈압 진단 기준 — 미국 2025 ≥130/80 · 국내(대한고혈압학회 2022) 1~2주 평균 ≥135/85. 국내 진료는 135/85로 판단합니다.

**≥130/80 mmHg**

**미국 기준 (가정)**

국내는 ≥135/85

**2회×2 /일**

**측정 횟수**

최소 1주 평균



그림 · 가정혈압 측정 — 진료실보다 더 중요해졌습니다

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · AHA Statement on Home BP Monitoring 2022 · 2025 Guideline 권고

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 1차 치료 — 생활습관 6가지

Life's Essential 8 — 가장 강력한 단일 인자는 체중·식이·운동의 조합

### DASH 식이

채소·과일·통곡물·저지방 유제품 위주. 수축기 8-14 mmHg 감소 효과 입증.

### 저나트륨 (소금)

하루 2,000 mg 이하(소금 5g, 세계보건기구). 한국인 평균은 3,136 mg(2023)입니다.

### 고칼륨 식이

하루 3,500-5,000 mg. 바나나·시금치·고구마·콩. 중국 SSaSS 연구 사망 감소 입증.

### 체중 감량

1 kg 감량당 수축기 1 mmHg 감소. 비만 환자 가장 큰 효과.

### 중강도 유산소

주 150분 (걷기·자전거·수영). 수축기 4-9 mmHg 감소.

### 절주·금연·수면

음주 남 ≤2잔·여 ≤1잔/일. 금연 시 즉시 효과. 하루 7시간 수면.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · 2025 AHA/ACC · 세계보건기구 나트륨 지침 2012 · 국민건강영양조사 2023 · DASH · SSaSS 칼륨대체염 RCT (N Engl J Med 2021)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 약물치료 시작 시점 — 위험도 기준

심혈관질환 위험 예측도구(PREVENT) 10년 동맥경화성 심혈관질환 위험 ≥7.5%가 핵심 분기점

## 즉시 약물치료 시작

2기 고혈압 (≥140/90) — 위험도 무관 즉시 시작 (2가지 약 병용)
1기 + 고위험군 — 동맥경화성 심혈관질환 위험 ≥7.5%, 당뇨, 만성 콩팥병, 65세+
임상적 동맥경화성 심혈관질환 — 관상동맥질환, 뇌졸중, 말초혈관질환
심부전·심장 근육이 두꺼워진 상태 — 좌심실비대 동반 시 즉시 시작
※ 1기 + 저위험군은 생활습관 3-6개월 후 재평가, 미개선 시 약물 시작.

**≥7.5%**

**심혈관질환 위험 예측도구(PREVENT) 10년 심혈관질환 위험**
즉시 약물 기준

**-27%**

**SPRINT 근거**
엄격 강압 시 심혈관 위험

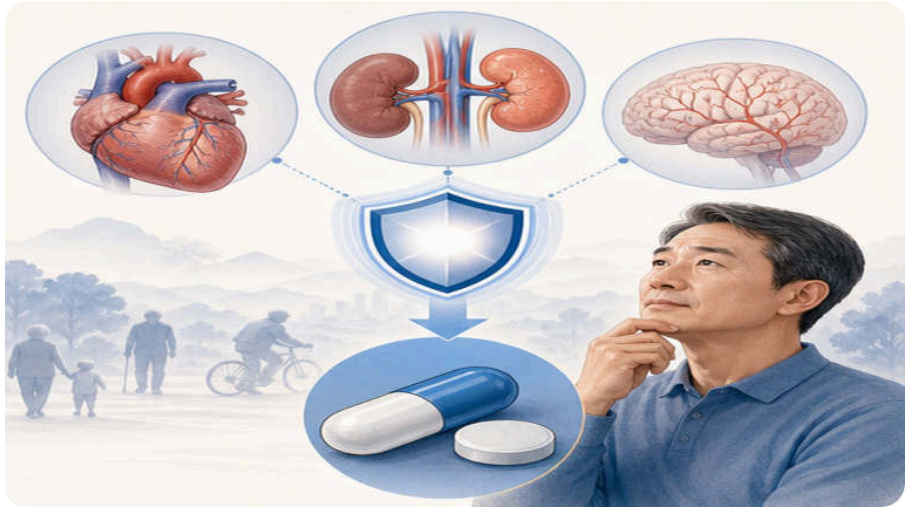


그림 · 약물치료 시작 시점 — 위험도 기준

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · SPRINT trial (NEJM 2015) · STEP trial (NEJM 2021) · 2025 AHA/ACC

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 1차 약물 4가지 계열

단일 약물보다 저용량 2가지 병용이 더 효과적·부작용 적음

### 안지오텐신 전환효소 억제제·안지오텐신 수용체 차단제

레닌-안지오텐신 차단. 당뇨·만성 콩팥병·심부전 동반 시 우선. 마른기침(안지오텐신 전환효소 억제제) 시 안지오텐신 수용체 차단제로 전환.

### 칼슘통로 차단제

암로디핀 등. 흑인·노인 효과 우월. 발 부종·잇몸증식 주의. 흉통 동반 시 우선.

### 티아지드 이뇨제

클로르탈리돈·인다파미드. 저렴·효과적. 혈중 칼륨·요산 모니터. 고혈압 약 비교 연구(ALLHAT) 1차 권장.

### 한 알에 두 성분을 담은 복합제

안지오텐신 수용체 차단제 + 칼슘통로 차단제 또는 안지오텐신 수용체 차단제 + 이뇨제. 복용 순응도↑·혈압 조절률↑. 1차 권장.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · 2025 AHA/ACC · 한 알에 두 성분을 담은 복합제 임상시험 메타분석 (Lancet 2021)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 진단·치료 흐름 4단계

고혈압 진단부터 안정 목표 도달까지의 표준 일정

### 진단 시점

평가·위험도 산정 진료실 ≥2회 + 가정혈압 1주 평균. 혈액·소변·심전도·심혈관질환 위험 예측도구(PREVENT) 위험.

### 1-3개월

생활습관·약물 시작 DASH 식이·운동·체중 시작. 2기·고위험은 즉시 약물. 4주 후 재평가.

### 3-6개월

용량 조정 목표 미달 시 용량↑ 또는 2차 약물 추가. 부작용 점검.

### 6개월 이후

안정 유지·연간 평가 내 목표(진료실에서 정함) 도달 후 매 3-6개월 추적. 합병증·신기능 매년.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · 2025 AHA/ACC HTN Guideline 진료 흐름도

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 응급 증상과 중증 혈압을 구별하세요

증상이 있으면 응급실, 증상 없이 매우 높으면 신속히 외래 진료

### 갑작스런 심한 두통

평소와 다른 강도, 구토 동반. 뇌출혈·고혈압성 뇌병증 가능성.

### 시야 흐림·복시

갑자기 한쪽 눈 시야 손상, 망막 부종 또는 망막혈관 손상 가능성.

### 흉통·호흡곤란

압박감 또는 쥐어짜는 통증, 식은땀 동반. 급성 관상동맥·심부전 의심.

### 팔·다리 한쪽 마비

말 어눌함, 안면 비대칭. 급성 뇌졸중 — FAST 원칙, 골든타임 4.5시간.

### 코피·요혈

압박해도 멎지 않는 코피, 소변 색 갈색·붉음. 표적 장기 손상 신호.

### 혈압 ≥180/120

반복 측정해도 ≥180/120이면 중증 고혈압입니다. 증상이 없으면 신속히 외래 진료를 받으세요.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · 2025 AHA/ACC Hypertensive Emergency 정의 · 응급 가이드라인

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 한국 진료지침과의 간극 — 적용 시 고려

KSH 2022 vs 2025 AHA/ACC — 일반 환자 목표 차이를 함께 검토

## 주요 차이점

일반 성인 목표 — KSH 2022 <140/90 vs AHA/ACC 2025 <130/80
고위험군 목표 — 양쪽 모두 <130/80 (일치)
1기 시작 시점 — KSH 6-12개월 후 vs AHA 3-6개월 후
한국인 특성 — 짠 음식 섭취·신부전 동반 비율 높음

## 참고

※ 보험 급여·약물 보험 기준은 KSH 기준 적용. 임상 판단 시 환자 위험도 + 합병증을 함께 고려해 개별화합니다.

## 광교바른내과 접근

고위험 · <130/80 · 당뇨·만성 콩팥병·심혈관질환 시

## 일반

기본 · <140/90 · 개별 위험 따라 조정

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · KSH 2022 한국 고혈압학회 진료지침 · 2025 AHA/ACC 비교

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 환자 실천 체크리스트 7가지

진단 직후부터 시작할 수 있는 구체적 행동

**01** 가정혈압 매일 아침·저녁 2회씩 5분 안정 후 1분 간격 2회 측정. 평균치 기록. 진료 시 1주 기록 지참.

**02** 소금 줄이기 (나트륨 2,000 mg/일 이하) 국·찌개 국물 줄이기, 라면·즉석식 피하기. 영양정보 라벨 확인 습관.

**03** 칼륨 식품 늘리기 바나나·시금치·고구마·콩·아보카도. 신부전 환자는 제한 — 의사 확인.

**04** 주 150분 빠르게 걷기 하루 30분 × 5일. 식후 산책 더하면 혈압 조절·체중 모두 개선.

**05** 약 거르지 않기·시간 고정 매일 같은 시간 복용. 잊었을 때 12시간 이내면 바로, 이후면 다음 시간.

**06** 절주·금연 시작 음주 남 ≤2잔·여 ≤1잔/일. 금연은 즉시 — 시작 1년 내 효과 큼.

**07** 3-6개월마다 재검 혈압·신기능·전해질·소변 알부민 추적. 합병증 매년 종합 평가.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · 2025 AHA/ACC · KSH 2022 · 광교바른내과 표준

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 다시 보기 · 문의

QR로 다시 보기 · 집에서 재는 법과 기록지는 가정혈압 안내문을 드립니다

## 광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

## 이 자료의 성격

환자와 보호자를 위한 설명자료입니다. 진단과 처방은 담당 의료진과 상의하세요.

## 참고한 자료

AHA/ACC 2025 고혈압 지침 · 대한고혈압학회 2022 지침

SCAN TO REVISIT

**집에서 다시 보기**

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요